

MATAVICIOS · GUÍA PRÁCTICA PARA ADULTOS

Cambiar tu relación con el cannabis.

Una guía de autoayuda para observar tu patrón, reducir riesgos, preparar cambios y pedir apoyo cuando sea necesario.

Objetivo flexible

Seguridad primero

Seguimiento realista

Antes de empezar. Este es un material educativo de autoayuda. No diagnostica, no prescribe tratamientos y no sustituye la valoración de medicina, enfermería, farmacia, psicología o psiquiatría.

Úsalo para observar tu patrón, probar cambios pequeños y pedir apoyo cuando lo necesites. No se trata de demostrar fuerza de voluntad ni de seguir una racha perfecta. Se trata de ganar margen de elección.

Cómo está organizado

MÓDULO 0

Empezar con seguridad

MÓDULO 1

Conocer tu patrón

MÓDULO 2

Decidir sin pelearte contigo

MÓDULO 3

Urgencias, abstinencia y sueño

MÓDULO 4

Pensamientos, emociones y actividades

MÓDULO 5

Entorno, apoyo y refuerzo personal

MÓDULO 6

Aprender de un episodio y pedir ayuda

MÓDULO 7

Mantener un plan flexible

Empezar con seguridad

Esta guía es para personas adultas que quieren cambiar su relación con el cannabis. No diagnostica un trastorno ni reemplaza la atención profesional.

Consumo, preocupación y posible trastorno

El **trastorno por uso de cannabis (TUC; CUD en la bibliografía inglesa)** es un diagnóstico clínico. Se refiere a un patrón de uso que causa malestar o dificultades importantes y se valora junto con el contexto, la salud mental, otras sustancias y otros diagnósticos posibles. Consumir cannabis no convierte automáticamente a nadie en una persona con TUC. Si te preocupa tu uso, esta guía puede ayudarte a recoger información para una conversación profesional. [\[1\]](#) [\[5\]](#)

Tu objetivo de los próximos siete días

Puedes elegir dejar, reducir, retrasar el primer consumo, cambiar un contexto de uso o pedir una evaluación. No hay una única meta correcta. La meta más útil es la que puedes observar y revisar.

HERRAMIENTA · MI SIGUIENTE PASO

Mi objetivo elegido: _____

Por qué importa para mí: _____

Fecha de inicio o revisión: _____

Persona o servicio de apoyo: _____

Seguridad antes que rachas

- ❑ No conduzcas, uses maquinaria ni tomes decisiones de riesgo si estás intoxicado, muy privado de sueño o has mezclado sustancias.
- ❑ No uses alcohol, benzodiacepinas, suplementos, CBD u otros sedantes para “automedicar” la abstinencia o el sueño sin valoración sanitaria.
- ❑ Busca orientación profesional desde el inicio si eres menor de edad, estás embarazada o en lactancia, tienes psicosis actual o previa, bipolaridad/manía, riesgo suicida/autolesivo, policonsumo significativo o una condición médica compleja.

ATENCIÓN URGENTE

Usa emergencias locales ante ideas de suicidio o autolesión, alucinaciones o paranoia, confusión, agitación intensa, riesgo de violencia, dolor torácico, dificultad respiratoria o incapacidad para mantenerte a salvo.

Conocer tu patrón

La cadena de consumo no se reduce a una sustancia o a una emoción. Mira la situación, la disponibilidad, lo que buscabas y lo que ocurrió después.

Registro de uso y urgencia

SITUACIÓN / PRODUCTO	EMOCIÓN, SENSACIÓN O PENSAMIENTO	OTRAS SUSTANCIAS / DISPONIBILIDAD	QUÉ HICE	EFEECTO INMEDIATO Y POSTERIOR
Fin de jornada / _____	“Quiero apagar el día”	Alcohol / tabaco / material a mano	Consumí	Relajación breve / dormí tarde
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Añade producto, vía de uso y cantidad aproximada si te ayuda. No necesitas convertirlo en una medición perfecta: busca patrones que puedas comentar con claridad.

Señales frecuentes, no una lista cerrada

Fin de jornada, amigos que consumen, insomnio, ansiedad, dolor, música, sofá, disponibilidad, alcohol o tabaco pueden aparecer en algunos patrones. No son causas universales. Escribe también qué disminuye la urgencia: un lugar, una actividad, una persona, una hora o una rutina.

PRÁCTICA · SIETE DÍAS DE OBSERVACIÓN

Registra cada día consumo o urgencia, sueño, ánimo, intensidad de la urgencia de 0 a 10, otras sustancias y una estrategia que probaste. La información sirve para ajustar, no para castigarte.

Potencia y productos

La concentración de THC y la forma de consumo varían mucho entre flor, resina, extractos, comestibles y mercados. Evita cifras únicas sobre potencia sin saber producto, país, periodo y fuente. Los productos concentrados pueden aportar dosis altas de THC y merecen atención específica en una consulta. [\[6\]](#)

MÓDULO 2

Decidir sin pelearte contigo

La ambivalencia es común: puede haber razones para cambiar y razones para seguir. Explorar ambas con honestidad suele ser más útil que confrontarte.

Balanza de decisiones

	SEGUIR COMO HASTA AHORA	CAMBIAR MI PATRÓN
Lo que obtengo	_____	_____
Lo que me cuesta	_____	_____
Lo que temo	_____	_____
Apoyo que necesito	_____	_____

Importancia y confianza

En una escala del 0 al 10: **¿qué tan importante es cambiar ahora?** ____; **¿cuánta confianza tienes en dar un primer paso?** _____. Después pregunta: “¿Por qué no elegí un número más bajo?” y “¿Qué haría subir un punto mi confianza?”. Esta conversación contigo se inspira en enfoques motivacionales y no sustituye una terapia de mejora motivacional. [\[4\]](#)

Declaración flexible

MI DECLARACIÓN DE CAMBIO

“Durante esta semana, elijo _____ porque quiero cuidar
_____. La ayuda que acepto es _____.”

Revísala cuando te resulte útil. Ajustarla no es fracasar: puede ser aprender qué meta es viable ahora.

MÓDULO 3

Urgencias, abstinencia y sueño

Si reduces o dejas cannabis con THC, pueden aparecer cambios temporales. Prepararlos no significa que vayan a ocurrirte todos ni que debas soportarlos sin ayuda.

Qué puede pasar al reducir o dejar

Algunas personas, especialmente si consumían con regularidad, notan irritabilidad, ansiedad, alteraciones del sueño o sueños vívidos, menor apetito, ánimo bajo y deseo intenso de consumir. Suelen empezar entre 24 y 48 horas después de una reducción importante, alcanzar mayor intensidad aproximadamente entre los días 2 y 6 y, en algunas personas, durar tres semanas o más. La intensidad y duración varían. [\[2\]](#)

CONSULTA SI SE COMPLICA

Busca valoración si los síntomas son intensos, persistentes, afectan a tu seguridad o funcionamiento, o aparecen paranoia, confusión, ideas de autolesión, síntomas de manía o consumo de otras sustancias para manejarlos.

Plan breve para una urgencia

1. **Reconoce:** “Estoy notando una urgencia de consumir”.
2. **Retrasa una decisión:** elige unos minutos que te parezcan posibles.
3. **Cambia el contexto:** aléjate de material, pantalla, lugar o compañía asociada si es seguro hacerlo.
4. **Elige una alternativa:** agua/comida si procede, mensaje a alguien, música, paseo suave si es seguro, tarea concreta o respiración cómoda.
5. **Reevalúa:** anota si la urgencia bajó, se mantuvo o aumentó.

Esto no es HRT ni una desintoxicación. Es un experimento de autoayuda. Si una técnica te hace sentir peor, para y elige otra.

Rutina de sueño no rígida

Mantén una hora aproximada de levantarte, limita las pantallas que te activan antes de acostarte y prepara una actividad tranquila con luz tenue. Si permaneces despierto y frustrado durante un rato, puede ayudar salir de la cama para hacer algo calmado y volver cuando aparezca sueño. Adáptalo a turnos, crianza, dolor o discapacidad. Pide valoración por insomnio persistente, ronquidos/pausas respiratorias, síntomas de manía o somnolencia que afecte a la conducción.

Pensamientos, emociones y actividades

Una respuesta útil no tiene que negar que el cannabis pueda haber dado alivio, placer o rutina. Puede mirar el conjunto y ampliar tus opciones.

Registro de pensamiento completo

SITUACIÓN	PENSAMIENTO	BENEFICIO A CORTO PLAZO	COSTE A CORTO/LARGO PLAZO	ALTERNATIVA QUE PROBARÉ
Después del trabajo	“Lo necesito para relajarme”	Me marca una pausa	A veces postergo tareas y duermo peor	Caminar, ducha o música antes de decidir

La TCC no consiste en imponer frases como “la relajación real es...”. Consiste en observar tu evidencia, los efectos a distintos plazos y las alternativas disponibles.

Pausa de cuatro pasos

Si te ayuda, prueba una pausa breve: **reconoce** la urgencia; **permite** que esté presente sin obedecerla; **observa** cuerpo, pensamiento y contexto con suavidad; y **vuelve** a una acción elegida. Si prestar atención interna aumenta pánico, disociación o recuerdos traumáticos, oriéntate a objetos del entorno y consulta a un profesional.

Alternativas que cumplen una función

En vez de buscar un sustituto universal, escribe qué función buscabas y prueba opciones realistas.

Descansar

Música, ducha, lectura, actividad tranquila, siesta breve si encaja con tu sueño.

Conectar

Mensaje, llamada, actividad compartida o apoyo profesional.

Cambiar de estado

Paseo suave, tarea manual, salir al exterior o respiración cómoda.

Distraerme

Una tarea breve con principio y final, juego no relacionado con apuestas o una serie con límite acordado.

Entorno, apoyo y refuerzo personal

No necesitas aislarte ni destruir relaciones para cambiar. Puedes rediseñar accesos, acordar límites y aumentar el contacto con quienes apoyan tu objetivo.

Cambios ambientales que respetan tu realidad

- Retira o guarda de forma segura objetos asociados al consumo si es posible y no abre un conflicto doméstico.
- Silencia o elimina accesos que no deseas conservar sin reabrir conversaciones innecesarias.
- Prepara una actividad y un espacio alternativos para los momentos de mayor riesgo.
- Si convives con personas que consumen, plantea límites realistas sobre espacios, oferta y momentos compartidos.
- Observa cannabis con tabaco, alcohol u otras sustancias: pueden aumentar el riesgo de que el plan sea más difícil.

Mapa de apoyo y co-consumo

Mi mapa social

Personas que apoyan mi objetivo:

Situaciones que necesito negociar:

Sustancias o contextos que aumentan mi riesgo:

Plan de salida o transporte seguro:

Refuerzo personal no es “contingency management” clínico

La gestión de contingencias (CM) es un procedimiento clínico estructurado con incentivos vinculados a una conducta objetivo y, con frecuencia, verificación objetiva. Una recompensa personal no es lo mismo y no debe venderse como CM. Aun así, puede ayudarte elegir recompensas legales, asequibles y no relacionadas con sustancias por cumplir acciones bajo tu control: completar el registro, acudir a una cita, practicar una rutina o mantener un límite. La rapidez y el importe los decides tú.

Aprender de un episodio y pedir ayuda

Un uso no planificado puede requerir una revisión y, a veces, más apoyo. No necesita convertirse en castigo ni en el abandono de todo el plan.

Distingue sin dramatizar

Define antes qué significa para ti un consumo planificado, un episodio no planificado, un retorno a un patrón que no deseas y una meta revisada. Un episodio puede reactivar deseos o señales asociadas para algunas personas; no borra lo que aprendiste ni obliga a pensar que el cambio es imposible.

Plan de las próximas 24 horas

1. **Reduce riesgos inmediatos:** no conduzcas ni tomes decisiones importantes si estás bajo efectos; aléjate de situaciones inseguras.
2. **Registra la cadena:** situación, sustancia(s), necesidad, disponibilidad, apoyo ausente y efecto posterior.
3. **Conecta:** avisa a una persona segura o pide una cita.
4. **Haz un ajuste único:** cambia un acceso, un plan social o una estrategia para las próximas 48 horas.
5. **Retoma tu objetivo:** en la siguiente elección, sin esperar un lunes.

SOBRE EJERCICIO Y “DESINTOXICACIÓN”

El movimiento suave o moderado puede apoyar ánimo, bienestar y rutina si te resulta seguro. No es una desintoxicación ni una forma fiable de acelerar la eliminación de cannabis. Evita ejercicio si estás intoxicado, mareado, muy privado de sueño o tienes una contraindicación médica.

Cuándo es buena idea una evaluación

Considera pedir ayuda si el consumo o la reducción causa problemas en trabajo, estudios, relaciones, economía, salud o seguridad; si has intentado cambiar sin lograr el objetivo; si hay alcohol, nicotina, benzodiazepinas u otras sustancias; o si usas cannabis para manejar dolor, trauma, ansiedad, depresión o sueño. TCC, enfoques motivacionales y terapia familiar son opciones psicosociales que pueden ofrecerse; sus resultados no están garantizados y la evidencia global es limitada. [3] [4]

MÓDULO 7

Mantener un plan flexible

No existe una curva universal de recuperación. Algunas molestias pueden mejorar gradualmente y otras necesitan apoyo adicional. Mide cambios reales en tu vida, no una imagen ideal de progreso.

Revisión semanal

SEMANA	OBJETIVO Y CONSUMO	SUEÑO/ÁNIMO 0-10	URGENCIA 0-10	FUNCIONAMIENTO	AJUSTE
1		/			
2		/			
3		/			
4		/			

Cierra cada revisión con tres preguntas: ¿qué mantengo?, ¿qué cambio?, ¿a quién consulto?

Plan de 30–90 días, no un plazo de “cura”

Si te resulta útil, amplía el plan a 30, 60 o 90 días. Es un horizonte de seguimiento, no una dosis terapéutica ni un “reseteo”. Revisa la meta cada semana y añade apoyo si empeoran el sueño, el ánimo, la urgencia o el funcionamiento.

MI SIGUIENTE CICLO

Meta de la próxima semana: _____

Un contexto que voy a preparar: _____

Recompensa o apoyo elegido: _____

Señal de que pediré cita: _____

El método en una página

MI SECUENCIA PERSONAL

1. Observo contexto y urgencia. 2. Creo una pausa posible. 3. Cambio acceso o actividad. 4. Pido apoyo si lo necesito. 5. Registro sueño, ánimo y funcionamiento. 6. Ajusto sin castigo.

Apoyo y recursos

Atención primaria o recursos de adicciones

Pueden valorar salud mental, sueño, otras sustancias, medicación y opciones de apoyo psicológico.

Persona de apoyo y transporte seguro

Escribe quién puede acompañarte o ayudarte a evitar conducir o exponerte a situaciones de riesgo.

Emergencias locales

Úsalas ante crisis de seguridad, ideas de autolesión, psicosis, confusión o síntomas físicos graves.

Privacidad y datos

Tus registros pueden incluir información sensible. Guárdalos de forma local y comparte solo lo que decidas.

Fuentes y transparencia

Las herramientas de esta guía se inspiran en enfoques conductuales, cognitivos y de aceptación. La evidencia no permite garantizar un resultado individual ni convertir esta guía en terapia. Las fuentes se incluyen para que puedas comprobar qué se sabe y qué límites tiene.

1. [SAMHSA \(2026\). *Addressing Cannabis Use Disorder in Primary Care Settings: A Lifespan Approach*.](#)
2. [Connor JP, et al. \(2022\). *Clinical management of cannabis withdrawal*. *Addiction*.](#)
3. [Köppe S, et al. \(2025\). *Effectiveness and safety of psychosocial interventions for cannabis use disorder: systematic review*. *Addiction*.](#)
4. [World Health Organization. *Psychosocial interventions for the management of cannabis dependence*.](#)
5. [Centers for Disease Control and Prevention. *Understanding your risk for cannabis use disorder*.](#)
6. [European Union Drugs Agency \(2025\). *European Drug Report: Cannabis — current situation in Europe*.](#)

Matavicios · Material de educación y autoayuda para adultos. Versión editorial revisada: septiembre de 2026. Si digitalizas tus ejercicios, protege tu privacidad: no compartas detalles sensibles en espacios no moderados y revisa dónde se guardan tus datos.